

1.STATE TRASPORTANDO AL DOMICILIO UN PAZIENTE DIALIZZATO. IMPROVVISAMENTE PERDE COSCIENZA COSA FATE?

- A Aspettate che si riprenda
- B Valutate coscienza e respiro, se necessario iniziate le manovre di rianimazione avvisando
il sistema d'Emergenza 112/118
- C vi preoccupate di dare informazioni ai parenti
- D lo trasportate al Pronto Soccorso più vicino

2.QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA COSTATAZIONE DI DECESSO È VERA?

- A serve solo per le pratiche burocratiche.
- B può essere compilata da qualsiasi medico.
- C può essere compilata solo dal medico di famiglia.
- D non è necessaria in caso di morte naturale.

3.COSA DEVE FARE L' ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE NEL CASO SI TROVI A TRANSITARE SUL LUOGO DI UN INCIDENTE STRADALE

- A Fermare il veicolo in sicurezza e allertare il sistema di emergenza sanitaria
- B Chiamare le forze dell'ordine e garantire la viabilità
- C Proseguire con il trasporto in quanto non abilitati al soccorso
- D Caricare e trasportare i feriti in ospedale

4.IL VICINO DI CASA DEL PAZIENTE CHE TRASPORTATE VI CHIEDE INFORMAZIONI SUL SUO STATO DI SALUTE. COSA FATE?

- A non rispondete e dite di rivolgersi ai famigliari
- B spiegate al vicino i segni, i sintomi e la probabile diagnosi
- C negate che il paziente sia sul vostro mezzo
- D non fornite informazioni e lo pregate di rispettare la privacy del paziente

5.CHE COSA SI INTENDE PER TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE (TSS)?

- A Trasporto di persone sprovviste di mezzi propri presso strutture private
- B Trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica, necessitano di accompagnamento protetto presso strutture sanitarie e socio-sanitarie
- C Trasporto di persone che presentano lesioni semplici
- D Nessuna delle precedenti

6.L'AUTISTA DEI MEZZI DI SOCCORSO (MSB/MSA/MSI):

- A deve essere in possesso della certificazione regionale di Soccorritore-esecutore
- B deve avere solo una buona conoscenza del territorio di riferimento
- C è obbligato ad avere un certificato di guida veloce
- D deve avere la patente C

7.LA LEGGE CHE NORMA L'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI AL PERSONALE NON SANITARIO (legge 120/2001):

- A Consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera
- B Consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera a tutti i cittadini
non medici che abbiano ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione
cardiopulmonare
- C Consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera a tutti i
soccorritori
- D Consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera a tutti i
soccorritori purché sia fatta a bordo delle ambulanze

8.L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DL. 18/03/2011) HA DI NORMA LA DURATA DI:

- A Non superiore ai 24 mesi
- B 5 anni
- C non ha limiti di tempo
- D 3 anni

9.IN CASO DI IMPERIZIA, DI CHI E' LA RESPONSABILITA' DELL'USO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO?

- A Del Direttore Sanitario dell'Ente/Associazione di Soccorso
- B Della SOREU e della AAT territorialmente competenti
- C Del Presidente dell'Ente/Associazione di Soccorso
- D Del Soccorritore

10.L'AUTORIZZAZIONE ALLA DEFIBRILLAZIONE SEMIAUTOMATICA HA VALORE REGIONALE?

- A È necessario un aggiornamento/riaddestramento entro 24 mesi
- B Basta comunicarlo al Presidente dell'Ente/Associazione di Soccorso
- C È sufficiente una comunicazione alla AAT di competenza
- D Non è necessario alcun tipo di aggiornamento

11.UNA CIRCONSTANZA IN CUI IL SOCCORRITORE PUO' NON INIZIARE LA RCP E':

- A Quando è certo che il paziente non sopravvivrà
- B Quando pensa che la vittima riporterà un danno cerebrale permanente
- C Quando sono evidenti lesioni incompatibili con la vita (decapitazione, carbonizzazione, lesioni incompatibili con la vita)
- D Quando non vede reazione pupillare o altri segni di vita

12.STATE FACENDO UN TRASFERIMENTO EXTRA-PROVINCIA IN LOMBARDIA E TROVATE UN MALORE IN STRADA; AVETE A BORDO IL DAE, COSA FATE?

- A Fate la valutazione, contattate la SOREU territorialmente competente e riferite di avere il DAE, ma di non poterlo utilizzare perché siete fuori dalla vostra provincia
- B Fate la valutazione, contattate il numero unico dell'emergenza e riferite di avere iniziato la procedura di BLSD-BLS Laico, secondo il protocollo regionale
- C Fate la valutazione, e attendete il mezzo inviato dalla SOREU territorialmente competente
- D Componete il numero 112 e chiedete di mettervi in comunicazione con la vostra SOREU per chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del DAE fuori provincia.

13.SECONDO IL DL. DEL 18 Marzo 2011 "DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI" LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE È AFFIDATA A:

- A Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
- B Ministero della Salute
- C Associazioni ed Enti di Soccorso
- D AREU

14.IL "NUE 112" COINVOLGE:

- A Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno
- B L'Arma dei Carabinieri
- C I Vigili del Fuoco e l'Emergenza Sanitaria
- D Tutte le Istituzioni elencate nei punti precedenti

15.SI DEFINISCE TRASPORTO SANITARIO:

- A trasporto di persone ammalate verso ospedali case di cura

- B trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria Specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie
- C qualsiasi trasporto con ambulanza di persone non autosufficienti
- D trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di ricovero e cura, ovvero all'interno delle medesime (inter ed intra ospedaliero, da e verso ospedali dal domicilio)

16.IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E TRASPORTO SANITARIO, DEVE:

- A avere compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età
- B avere buona conoscenza della lingua italiana
- C sostenere e superare il percorso formativo previsto
- D avere tutti i requisiti sopra elencati

17.NEL CASO DI COINVOLGIMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA URGENZA SANITARIA (ES. INCIDENTE STRADALE) GLI OPERATORI ADDETTI AL TRASPORTO SANITARIO:

- A sono tenuti a contattare immediatamente il Servizio di Emergenza Sanitaria (112/118) e ad attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute
- B sono obbligati a trasportare le vittime al più vicino pronto soccorso
- C non possono intervenire se non stanno utilizzando un'ambulanza
- D sono obbligati a gestire almeno la viabilità

18.I MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SANITARIO SONO:

- A furgoni finestrati attrezzati per il trasporto dei disabili
- B autovetture e furgoncini
- C autovetture, furgoni finestrati e autoambulanze
- D ambulanze

19.DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO È VIETATO:

- A utilizzare i dispositivi acustici e visivi supplementari di segnalazione, salvo su eventuale indicazione della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118
- B svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario
- C assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto
- D tutte le precedenti



- C il polso carotideo
- D il polso apicale

10. NELL'ABCDE PRIMARIO, IN QUALE ORDINE AVVIENE LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI?

- A coscienza, respiro, circolo, valutazione neurologica, esposizione e protezione del paziente
- B respiro, circolo, coscienza, valutazione neurologica ed esposizione e protezione termica
- C esposizione e protezione del paziente, respiro, circolo, coscienza, valutazione neurologica
- D pressione arteriosa, circolo, coscienza, valutazione neurologica ed esposizione e protezione del paziente

11. CHE COSA SI INTENDE PER "COLPO D'OCCHIO"?

- A Il soccorritore valuta se il torace del paziente si muove
- B Il soccorritore valuta globalmente e sommariamente la gravità del paziente mentre si avvicina
- C Il soccorritore valuta la risposta pupillare del paziente
- D Il soccorritore valuta se sul luogo sono presenti tutti i soccorritori

12. IN QUALE DEI SEGUENTI CASI LA FREQUENZA RESPIRATORIA E' ALTERATA?

- A 18 atti in un adulto
- B 30 atti in un ragazzo di 18 anni con crisi asmatica
- C 12 atti in un anziano con dolore al torace
- D 20 atti in una donna con dolore addominale



TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO D
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE DA
ASSISTERE E TRASPORTARE



1. IL COLLARE CERVICALE PUÒ ESSERE CONTROINDICATO IN CASO DI:

- A paziente cosciente, senza deficit neurologici agli arti
- B difficoltà a ottenere la posizione neutra per dolore o contrattura muscolare
- C non ci sono controindicazioni
- D difficoltà respiratoria

2. E' CONSIGLIATO L'UTILIZZO DEL COLLARE NEL BAMBINO DI 10 ANNI TRAUMATIZZATO?

- A no se muove correttamente i 4 arti e non lamenta dolori al collo
- B sì sempre
- C solo se incosciente e in caso di grave sospetto di lesione midollare
- D no se si oppone piangendo

3. L'ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO PUO' RIMUOVERE IL CASCO:

- A sì, se riceve istruzioni
- B sì, se si ha in dotazione il collare cervicale
- C no
- D no, solo se la vittima è in arresto cardiocircolatorio

4. IN CASO DI UN ARTO FRATTURATO, COME SI DEVE IMMOBILIZZARE?:

- A immobilizzare l'arto con steccobenda
- B raddrizzare l'arto anche forzandolo e steccarlo
- C ripristinare la posizione anatomica trazioneando l'arto
- D trasportare il paziente così com'è sulla barella

5. UNA SOSPETTA FRATTURA SEMPLICE E COMPOSTA DI GAMBA DEVE ESSERE IMMOBILIZZATA:

- A come prima cosa
- B dopo aver fatto l'ABCDE primario, prima di mobilizzare il paziente
- C senza precauzioni poiché non è esposta
- D solo in ambulanza

6. QUAL È, TRA QUELLE ELENATE, LA MIGLIORE MODALITÀ DI TRASPORTO DI UNA GRAVIDA ALLA 30^A SETTIMANA TRAUMATIZZATA?

- A supina ruotata leggermente sul lato destro
- B supina ruotata leggermente sul lato sinistro
- C supina semi seduta
- D prona

7. LA MANOVRA DI APERTURA DELLE VIE AEREE NEL PAZIENTE NON COSCIENTE:

- A mediante estensione del capo e sollevamento della mandibola
- B con le dita a pinza sulle labbra spingendo verso l'alto
- C con la posizione laterale di sicurezza
- D con l'aspirazione e lo svuotamento del cavo orale

8. IL MATERASSO A DEPRESSIONE:

- A è un sistema d'immobilizzazione del paziente in toto
- B necessità di tempi lunghi di posizionamento
- C per il corretto utilizzo richiede il posizionamento del collare cervicale e l'utilizzo della barella cucchiaino
- D tutte le precedenti risposte sono corrette

9. LA BARELLA CUCCHIAIO:

- A Si utilizza per il trasporto del paziente traumatizzato dal terreno all'ospedale



**TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO D
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE DA
ASSISTERE E TRASPORTARE**

- B Si utilizza per lo spostamento dal terreno al presidio più idoneo per il paziente che ha subito un trauma
- C Non si utilizza mai se è presente la tavola spinale
- D E' un presidio solo per pazienti con trauma lieve

10. COSA RISULTA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA DURANTE IL TRASPORTO DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE?

- A Raccogliere informazioni sulla sua patologia genetica
- B Assicurare una buona comunicazione e favorire la possibilità di trasportare la persona di riferimento
- C Non si possono trasportare se hanno una disabilità fisica importante
- D Nessuna delle precedenti

11. STAI TRASPORTANDO UNA PERSONA QUANDO IMPROVVISAMENTE PERDE COSCIENZA, COSA FAI?

- A Proseguo con il trasporto fino all'ospedale più vicino, attivando i dispositivi di emergenza
- B Fermo il veicolo, valuto la persona secondo lo schema ABCDE e attivo il 112 attenendomi alle indicazioni della SOREU
- C Inizio con le manovre rianimatorie e fermo il veicolo fino alla comparsa di segni di circolo
- D Avviso i parenti e condivido una strategia di comportamento sulla situazione

12. QUANDO SI TRASPORTA UNA PERSONA ANZIANA NON AUTO SUFFICIENTE È NECESSARIO TENERE IN CONSIDERAZIONE

- A Che tutte le persone anziane subiscono una graduale perdita di autonomia, fino anche alla difficoltà di percezione e comunicazione dei bisogni elementari
- B Che le persone anziane sono poco attente e quindi non necessitano di grande attenzione
- C Che le persone anziane possono subire una graduale perdita di autonomia nella gestione della propria persona causata da deficit motori, sensitivi e cognitivi
- D Nessuna delle precedenti

13. TRASPORTANDO UN PAZIENTE DIALIZZATO, TI ACCORGI CHE PERDE SANGUE DALLA FISTOLA ARTERO VENOSA, LUI RIMANE COSCIENTE E SI LAMENTA PERCHÉ NON È LA PRIMA VOLTA CHE CAPITA, COSA FAI?

- A Valuto il paziente secondo lo schema ABCDE
- B Tranquillizzo la persona e valuto il sanguinamento
- C Applico una compressione esterna, tramite delle garze, sulla fistola
- D Tutte le precedenti

14. DEVI EFFETTUARE UN TRASPORTO DA CASA VERSO L' OSPEDALE, DI UNA PERSONA CHE AL DOMICILIO UTILIZZA UN DISPOSITIVO PER VENTILAZIONE MECCANICA. DURANTE IL TRASPORTO SUONA UN ALLARME DEL DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE, COSA FAI?

- A Chiamo il medico di base e attendo istruzioni
- B Spengo l'allarme e posiziono una mascherina con O2 ad alti flussi
- C Proseguo con il trasporto fino all'ospedale più vicino, attivando i dispositivi di emergenza
- D Nessuna delle precedenti

15. PRIMA DI EFFETTUARE IL TRASPORTO DI UNA PERSONA CHE UTILIZZA UN DISPOSITIVO PER LA VENTILAZIONE MECCANICA, COSA DOVREMO VERIFICARE?

- A La compatibilità delle prese di alimentazione elettrica con l'apparecchio elettromedicali
- B La presenza di un apparecchio elettromedicale di scorta
- C Il livello di carburante



TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO D
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE DA
ASSISTERE E TRASPORTARE

D La presenza del manuale di istruzioni d'uso dell'apparecchio elettromedicale

16. VENITE INCARICATI DI EFFETTUARE IL TRASPORTO SECONDARIO DI UNA DONNA GRAVIDA, TRAUMATIZZATA, A TERMINE DI GRAVIDANZA. QUALE POSIZIONE È INDICATA?

- A Decubito laterale destro, con inclinazione di 20°, su tavola spinale
- B Decubito laterale sinistro, con inclinazione di 20°, su tavola spinale
- C Supina, con inclinazione di 30°, su tavola spinale
- D In posizione ginecologica, senza inclinazioni, su tavola spinale

17. PRIMA DI EFFETTUARE IL TRASPORTO DI UNA PERSONA CHE UTILIZZA UN SUPPORTO VENTILATORIO CON OSSIGENO, COSA DOVREMO VERIFICARE?

- A La presenza del manuale di istruzioni dell'apparecchio elettromedicale
- B Il livello di liquido nel flussimetro
- C Il livello di ossigeno delle bombole centrali e portatili
- D Nessuna delle precedenti

18. COSA BISOGNA OSSERVARE COSTANTEMENTE DURANTE IL TRASPORTO DI UNA PERSONA DIALIZZATA?

- A Il grado di coscienza del trasportato
- B I segnali di allarme sull'attività respiratoria prima e dopo la seduta di emodialisi
- C La misurazione della pressione arteriosa e la saturazione dopo la seduta di emodialisi nel caso di malore/spossatezza improvvisa
- D Tutte le precedenti



**TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO E
APPROCCIO PSICOLOGICO E
RELAZIONALE CON LE PERSONE MALATE**



- 1. DURANTE UN TRASPORTO IN UNA CASA DI RIPOSO PER UN PAZIENTE ANZIANO CON DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE, È NECESSARIO:**
 - A usare un tono di voce calmo
 - B cercare un contatto fisico, aiuta a rassicurarlo
 - C dare sempre il dovuto rispetto
 - D tutte le precedenti
- 2. NELL'ASSISTENZA AD UN UTENTE NON VEDENTE QUALI SONO GLI ACCORGIMENTI DA TENERE PRESENTI:**
 - A nessun accorgimento
 - B lasciare spazio alla necessità tattile
 - C parlare ad alta voce
 - D stare sempre a fianco del paziente
- 3. VENITE CHIAMATI PER UN TRASPORTO DALL' ABITAZIONE PER UN CONTROLLO RADIOLOGICO. ALL'ARRIVO TROVATE UN UOMO DI 30 ANNI, EXTRACOMUNITARIO, NON CONOSCETE LA SUA LINGUA, COME COMUNICATE CON LUI:**
 - A non è un problema, esagerano sempre, dicono di stare male, in realtà non hanno nulla
 - B cercando di utilizzare la comunicazione non verbale per capire cosa sta succedendo
 - C non è necessario comunicare, ma in silenzio eseguire la valutazione e portare il paziente in ospedale
 - D è opportuno aspettare fino all'arrivo di qualcuno che faccia da interprete
- 4. PER INSTAURARE UNA BUON RAPPORTO DI RELAZIONE CON IL PAZIENTE È NECESSARIO:**
 - A mostrare competenza e professionalità
 - B rispondere correttamente alle domande
 - C parlare con calma
 - D nessuna delle precedenti
- 5. STAI TRASPORTANDO UN BAMBINO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA:**
 - A Giochi con lui
 - B Compri e/o offri delle caramelle
 - C Se il genitore è presente lo trasporti con lui
 - D Accendi i dispositivi acustici per farlo divertire



TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO F
TECNICHE ASSISTENZIALI APPROCCIO AL
PAZIENTE



1. IL PAZIENTE DISPNOICO È UN PAZIENTE CHE:

- A non ha alcun interesse per quello che succede intorno a lui
- B ha difficoltà a digerire
- C fa fatica a respirare
- D è affetto da una malattia respiratoria cronica

2. PAZIENTE MOLTO SOFFERENTE PER DOLORE TORACICO:

- A rivalutare costantemente ABC in quanto è una patologia evolutiva
- B somministrare O₂
- C trasportare nella posizione più idonea tenendo presente la possibile evoluzione
- D tutte le precedenti risposte sono corrette

3. L'ASSISTENZA DI UN PAZIENTE SVEGLIO, POCO COLLABORANTE E ROSEO INCLUDE:

- A la frequente rivalutazione dello stato di coscienza
- B il posizionamento in posizione laterale di sicurezza
- C la necessità di parlare a voce molto alta
- D la somministrazione di zucchero

**4. DURANTE UN TRASPORTO SANITARIO, LE CONDIZIONI DEL PAZIENTE SI AGGRAVANO.
LE NOTIZIE PRINCIPALI DA TRASMETTERE ALLA SISTEMA D'EMERGENZA SANITARIA SONO:**

- A La residenza del paziente
- B Il peso del paziente
- C le condizioni di coscienza, respiro e circolo
- D il nome della struttura presso la quale è stato in passato curato il paziente

5. LA DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA È CONSIDERATA GRAVE QUANDO:

- A è presente cianosi
- B la frequenza respiratoria è minore di 10 o maggiore di 25/30 atti respiratori per minuto
- C il valore della saturimetria è minore di 90%
- D tutte le precedenti risposte sono corrette

6. IL DOLORE TORACICO DI ORIGINE CARDIACA:

- A inizia sempre in concomitanza con uno sforzo intenso
- B è caratterizzato da dolore retrosternale, sordo, descritto come pressione, restringimento/costrizione
- C si associa sempre a sudorazione e pallore
- D compare solo in soggetti maschi fra i 40 e i 70 anni

7. UN PAZIENTE ANZIANO E CARDIOPATICO RESPIRA CON FATICA (RESPIRO GORGOLIANTE)

- A lo invitare a tossire per espettorare e somministrare O₂
- B lo invitare a mantenere la posizione semi-seduta e somministrare O₂
- C lo obbligate a mantenere la posizione supina e somministrare O₂
- D gli lasciate a mantenere la posizione che preferisce

**8. UN UOMO SANO DI 43 ANNI HA LAMENTATO DOLORE TORACICO OPPRESSIVO AL CENTRO DEL
TORACE, ORA SCOMPARSO; PA, FC E FR SONO NORMALI:**

- A contattate il Sistema Sanitario d'emergenza e seguite le indicazioni
- B lo obbligate a seguirvi in ambulanza
- C lo trasportate sulla tavola spinale
- D suggerite un controllo in giornata presso il medico di base

9. SECONDO LA SCALA AVPU UN PAZIENTE "A" (ALERT):

- A risponde a tono alle domande e capisce quello che state dicendo
- B è incosciente ma reagisce ad uno stimolo verbale
- C si lamenta dopo uno stimolo
- D non risponde agli stimoli



10. UN PAZIENTE DISPNOICO:

- A non riesce a dire frasi lunghe senza interrompersi
- B ha una frequenza respiratoria elevata
- C mantiene obbligatoriamente la posizione seduta
- D tutte le precedenti risposte sono corrette

11. CON IL TERMINE PALPITAZIONI SI INTENDE:

- A rapida apertura e chiusura delle palpebre
- B fastidiosa percezione del proprio battito cardiaco
- C tremito regolare e fine delle mani
- D fastidiosa sensazione di svenimento

12. COSA SI INTENDE PER URGENZA MEDICA:

- A Condizione patologica che riceve il codice verde al triage in Pronto Soccorso
- B Condizione patologica che può essere valutata senza fretta dal medico di base
- C Condizione patologica che senza adeguato trattamento, entro poche ore compromette le funzioni vitali
- D Nessuna delle precedenti

13. COSA SI INTENDE CON L'ACRONIMO OPACS NELLA VALUTAZIONE DEL RESPIRO:

- A Ossigeno, palpazione, auscultazione, conto e saturimetria
- B Osservare, palpare, ascoltare, contare e saturimetria
- C Osservazione, palpazione, ascoltare, colorito e saturimetria
- D Ossigeno, palpare, auscultare, colorito e saturimetria

14. IL DOLORE TORACICO PUO' ESSERE:

- A Retrosternale
- B Irradiato ad altri punti
- C Oppressivo costrittivo trafittivo
- D Tutte le precedenti risposte sono corrette

15. LA SCALA DI CINCINNATI (CPSS) QUALI ASPETTI DEL PAZIENTE VALUTA?

- A I valori di pressione arteriosa, FR e FC
- B La presenza di difficoltà nella deambulazione
- C La mimica facciale, il sollevamento delle braccia e il linguaggio
- D Il linguaggio, il sollevamento degli arti inferiori e degli arti superiori

16. NELL'INDAGINE DEL DOLORE COSA SI DEVE CHIEDERE AL PAZIENTE?

- A Origine e insorgenza del dolore, da quanto tempo è insorto
- B Tipo di dolore, descrivere la qualità e l'intensità
- C Irradiazione, il dolore è fisso in un punto o tende a diffondersi in altri punti
- D Tutte le precedenti

17. CON TACHIPNEA SI INTENDE?

- A Frequenza respiratoria < a 10 atti al minuto
- B Frequenza respiratoria compresa tra 12 e 16 atti al minuto
- C Frequenza respiratoria > di 20 atti al minuto
- D Frequenza respiratoria di 12 atti al minuto

18. CON BRADIPNEA SI INTENDE?

- A Frequenza respiratoria < a 10 atti al minuto
- B Frequenza respiratoria compresa tra 12 e 16 atti al minuto
- C Frequenza respiratoria > di 20 atti al minuto
- D Frequenza respiratoria di 12 atti al minuto

19.CON TACHICARDIA SI INTENDE?

- A Frequenza cardiaca < a 60 battiti al minuto
- B Frequenza cardiaca tra 60 e 120 battiti al minuto
- C Frequenza cardiaca > di 120 battiti al minuto
- D Frequenza cardiaca di 80 battiti al minuto

20.CON BRADICARDIA SI INTENDE?

- A Frequenza cardiaca < a 60 battiti al minuto
- B Frequenza cardiaca tra 60 e 120 battiti al minuto
- C Frequenza cardiaca > di 120 battiti al minuto
- D Frequenza cardiaca di 80 battiti al minuto

21.COME SI PUO' PRESENTARE UN PAZIENTE BRADICARDICO?

- A Il paziente non presenta nessun segno particolare
- B Il paziente può presentare debolezza, affaticamento, sopore
- C Il paziente può presentare palpitazione, agitazione
- D Il paziente può presentare difficoltà di linguaggio

22.CON LO SCHEMA AMPIA SI VALUTANO?

- A Allergie, medicine, patologie, ingestione di cibo, altro riguardo al disturbo/evento attuale
- B Allergie, medicine, parametri vitali, ingestione di cibo, altro riguardo al disturbo/evento attuale
- C Allergie, malattie, parametri vitali, ingestione di cibo, altro riguardo al disturbo/evento attuale
- D Allergie, medicine, patologie, ingestione di farmaci, altro riguardo alla patologia attuale

23.LA DISPNEA E' PRESENTE QUANDO CI SONO:

- A Malattie a carico dell'apparato respiratorio
- B Malattie a carico del cuore
- C Malattie a carico del sistema nervoso centrale
- D Tutte le risposte precedenti sono corrette

24.UN PAZIENTE CON GRAVE DISPNEA SI PRESENTA:

- A Tranquillo appena viene posizionato l'O₂
- B Agitato con presenza di rumori respiratori, cianosi, saturazione < 90%
- C Agitato, frequenza respiratoria 12 atti al minuto
- D Tranquillo, frequenza respiratori 12 atti al minuto, iperteso, saturazione 96-98%

25.PER BRONCOPNEUPOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) SI INTENDE:

- A Patologia acuta a carico dei polmoni
- B Patologia infiammatoria cronica delle vie aeree inferiori che causa un'ostruzione del flusso aereo
- C Patologia allergica con presenza di tosse e febbre
- D Patologia infiammatoria caratterizzata da spasmo della muscolatura bronchiale ed edema della mucosa

26.QUALE POSIZIONE ASSUME UN PAZIENTE COSCIENTE DISPNOICO:

- A Prono
- B Supino
- C Decubito laterale destro
- D Seduto o semiseduto

27.UNA CRISI CONVULSIVA PUO' ESSERE CAUSATA DA:

- A epilessia e malattie del sistema nervoso centrale



- B trauma cranico
- C ipoglicemia
- D tutte le precedenti risposte sono corrette

28. UN PAZIENTE EPILETTICO NOTO HA AVUTO UN MALORE SULLE SCALE DI CASA. AL VOSTRO ARRIVO LO TROVATE SOPOROSO, IN POSIZIONE PRONA SUL PIANEROTTOLO, COME LO TRASPORTATE:

- A utilizzate il telo per il trasporto
- B posizionate il collare cervicale e utilizzate la tavola spinale
- C lo fate camminare fino al lettino
- D l'utilizzo del telo o della tavola spinale è indifferente

29. UN PAZIENTE 60 ANNI AL VOSTRO ARRIVO IN ABITAZIONE HA UNA CRISI CONVULSIVA IN ATTO

- A cercate di trattenerlo, forzate l'apertura delle vie aeree e somministrare O2
- B lo proteggete da possibili traumi senza trattenerlo, attendete la fine della crisi e iniziate con l'ABCDE
- C posizionate subito un collare per proteggere il rachide cervicale
- D non fate nulla



TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO G
TECNICHE DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE



1. LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE COMPRENDE

- Apronto riconoscimento di un'emergenza respiratoria e/o cardiaca
- B Attivazione del Sistema D'emergenza Sanitaria 112/118
- C l'esecuzione immediata della RCP
- D tutti i precedenti

2. LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, IN UN PAZIENTE APPARENTEMENTE INCOSCIENTE, DEVE AVVENIRE:

- Achiemando il paziente e scuotendolo delicatamente
- B pizzicando il paziente o eseguendo altre manovre che provocano esclusivamente dolore
- C controllando il diametro pupillare
- D eseguendo tutte le manovre precedenti

3. LE CTE SI EFFETTUANO CON IL PAZIENTE IN POSIZIONE:

- A laterale di sicurezza
- B come si trova se si sospetta un trauma
- C supina
- D si può fare in qualsiasi posizione, l'importante è che sia efficace

4. PER VALUTARE LA PRESENZA DI ATTIVITÀ RESPIRATORIA IL SOCCORRITORE DEVE:

- A applicare il saturimetro
- B Utilizzare il fonendoscopio
- C mettere il paziente semi seduto
- D osservazione rapidamente l'espansione toracica mentre valuta lo stato di coscienza

5. IN UN PAZIENTE ADULTO COSCIENTE, CON UN'OSTRUZIONE GRAVE DELLE VIE AEREE, IL SOCCORRITORE DEVE:

- A alternare 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali
- B effettuare 30 compressioni toraciche
- C tentare 2 insufflazioni
- D nessuno dei precedenti

6. SE IL PAZIENTE HA UN'OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE E TOSSISCE VIGOROSAMENTE:

- A somministra ossigeno ed assiste la ventilazione con pallone auto espansibile (Ambu)
- B ripeti 5 volte la manovra di Heimlich con paziente seduto
- C svuota il cavo orale utilizzando le dita o un aspiratore portatile
- D Invitalo a continuare a tossire e controlla che non peggiori

7. UN'OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE CON RESPIRAZIONE NON PIÙ SUFFICIENTE (TOSSE DEBOLE, RUMORI INSPIRATORI, COLORITO BLUAUSTRO, AUMENTATA DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA) RICHIEDE:

- A somministrazione d'ossigeno e rapido trasporto in ospedale
- B un'osservazione attenta del paziente
- C l'attuazione delle manovre di disostruzione
- D una richiesta d'aiuto

8. PER RESPIRO ANORMALE, AGONICO (GASPING) SI INTENDE:

- A attività respiratoria presente ma scarsa
- B attività respiratoria che precede l'arresto cardiaco
- C attività respiratoria che compare alla ripresa di circolo spontaneo
- D sporadici movimenti del torace, spesso associati a movimento paradossale, senza passaggio di aria

9. LE COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE E LA VENTILAZIONE HANNO LO SCOPO DI:

- A rallentare la degenerazione da morte clinica a morte biologica

- B interrompere una fibrillazione ventricolare
- C ridurre l'impedenza transtoracica
- D interrompere il danno anossico cerebrale

10. DURANTE LA FASE DI SHOCK L'OPERATORE DAE DEVE:

- A verificare la presenza di polso radiale del paziente
- B controllare il livello di carica delle batterie del DAE
- C assicurarsi che nessuno tocchi il paziente
- D sollevare il DAE da terra per evitare interferenze

11. PERCHÉ È NECESSARIO SOSPENDERE LA RCP DURANTE L'ANALISI EFFETTUATA DAL DAE?

- A per non ricevere una scarica elettrica
- B per non creare artefatti
- C per osservare se il paziente riprende attività cardiaca spontanea
- D per mantenere un circolo efficace

12. QUANTE SCARICHE CONSECUTIVE SI POSSONO EROGARE QUANDO IL DAE COMUNICA "SHOCK INDICATO"?

- A fino a tre, poi alternare RCP fino alla successiva analisi
- B nessuna se non si è ancora effettuato almeno 1 min. di RCP
- C 1 shock, poi riprendere la RCP fino all'analisi successiva
- D quante è possibile fino all'arrivo del MSA/MSI senza effettuare mai RCP

13. COSA FARE DOPO IL PRIMO SHOCK?

- A aspettare fino al prossimo ciclo di Analisi e Shock senza toccare il paziente
- B riprendere immediatamente le Compressioni Toraciche Esterne
- C ricercare segni di circolo e se assenti iniziare la RCP, in seguito seguire le indicazioni del 118
- D valutare la coscienza chiamando e scuotendo il paziente

14. LE COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE IN UN PAZIENTE ADULTO DEVONO ESSERE EFFETTUATE:

- A comprimendo il torace per una profondità di 4 – 5 cm
- B comprimendo il torace per una profondità di 5 – 6 cm
- C comprimendo con una sola mano
- D nessuna delle precedenti

15. L'OPERATORE DAE COME MANTIENE LA SICUREZZA DELLA SCENA?

- A enuncia ad alta voce la filastrocca "io sono via, voi siete via, tutti sono via" facendo guardare al collega soccorritore che nessuno si avvicini alla scena mentre guarda solamente il tasto di scarica per premerlo al momento giusto
- B enuncia ad alta voce la filastrocca "io sono via, voi siete via, tutti sono via" facendo attenzione ad allontanare l'ossigeno e dando uno sguardo tutto intorno al paziente subito prima di premere il tasto shock
- C enuncia ad alta voce la filastrocca "io sono via, voi siete via, tutti sono via" facendo attenzione che sia alla giusta distanza dai cavi mentre preme il tasto di shock
- D nessuna delle precedenti

16. IL TRATTAMENTO DELL'OSTRUZIONE GRAVE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NELL'INFANTE COSCIENTE COMPRENDE:

- A 5 colpi dorsali-interscapolari / 5 compressioni addominali (manovra di Heimlich)
- B 5 colpi dorsali-interscapolari / 5 compressioni toraciche
- C Compressioni addominali
- D Compressioni sub diaframmatiche



**TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO G
TECNICHE DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE**

17.IL TRATTAMENTO DELL'OSTRUZIONE GRAVE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO COSCIENTE COMPRENDE:

- A 5 colpi dorsali-interscapolari / 5 compressioni addominali (manovra di Heimlich)
- B 5 colpi dorsali-interscapolari / 5 compressioni toraciche
- C Compressioni addominali
- D Compressioni sub diaframmatiche



1. L'AMBULANZA TIPO "B" DI TRASPORTO

- A E' equipaggiata per i servizi di emergenza – urgenza
- B E' attrezzata per il trasporto non di emergenza con eventuale equipaggiamento di base
- C Non è dotata di dispositivi supplementari luminosi e acustici
- D Nessuna delle precedenti

2. QUALI TRA I SEGUENTI PRESIDI SONO CONSIDERATI "DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"

- A Camici monouso
- B Guanti monouso
- C Caschetti
- D Tutti i precedenti

3. LA DIVISA AD ALTA VISIBILITÀ

- A Può non rispettare le normative purché sia di colore visibile con bande riflettenti
- B Nella stagione estiva si può sostituire la giubba con una polo dell'associazione
- C Deve essere indossata sempre e ben allacciata
- D Non protegge dal contatto con liquidi

4. QUANDO NON SI UTILIZZA IL TELO DA TRASPORTO

- A Con paziente incosciente
- B Se il paziente pesa più di 75 Kg
- C In caso di paziente traumatizzato
- D Nell'anziano

5. PER L'UTILIZZO DEL TELO DA TRASPORTO SONO NECESSARI:

- A Almeno quattro soccorritori
- B Minimo tre soccorritori
- C Almeno due soccorritori
- D Solo soccorritori maschi visto l'impegno fisico

6. PER CALCOLARE L'AUTONOMIA DI UNA BOMBOLA DI O₂

- A Capacità della bombola x pressione disponibile / litri di erogazione
- B Capacità della bombola x litri di erogazione / pressione disponibile
- C Non occorre calcolare l'autonomia, ci sono le bombole di scorta
- D Nessuna delle precedenti

7. LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI

- A Può comportare dei rischi per la salute dell'operatore
- B E' differente a seconda del grado di collaborazione del paziente
- C Si effettua cercando di mantenere la propria schiena dritta flettendo le ginocchia a gambe leggermente divaricate
- D Tutte le precedenti

8. LA SEDIA CARDIOPATICA

- A Si usa solo per pazienti con problemi cardiaci
- B Si può usare con pazienti incoscienti se non si ha a disposizione il telo
- C Se il paziente è claustrofobico si può evitare di utilizzare le cinghie
- D Non si può utilizzare per il trasporto durante il viaggio in ambulanza

9. QUAL'È IL MODO CORRETTO PER TRASPORTARE UN BAMBINO NON TRAUMATIZZATO DI 7 ANNI A BORDO DI UN AMBULANZA?



TEST PRIMO MODULO
CAPITOLO I
IL TRASPORTO IN AMBULANZA



- A In braccio al genitore
- B telo portaferiti e barella
- C Seduto sul sedile nel vano sanitario in direzione di marcia
- D Sistema di ancoraggio a 5 punti (simil pedimate)